OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-01

Lésion osseuse solitaire · Bone-RADS

ACR Bone-RADS v2023
radiographie · score par points

Champ : lésion osseuse solitaire découverte en radiographie (ou analysée comme telle), chez l'adulte. On additionne les points des 6 critères ; le total donne la catégorie et la conduite. Pour le scanner et l'IRM, un système distinct existe (Society of Skeletal Radiology).

SCORE PAR POINTS (BONE-RADS V2023)

Marges (Lodwick)

IA géographique, bord **scléreux**	**1**
IB géographique, bien limité, **sans** sclérose	**3**
II géographique, mal limité	**5**
III A–C marges changeantes, mitées ou perméatives, ou invisibles	**7**

Réaction périostée

Aucune	**0**
Non agressive : solide, lisse, unilamellaire	**2**
Agressive : lamellée (« bulbe d'oignon »), spiculée (« feu d'herbe », « soleil »), éperon de Codman, désorganisée	**4**

Érosion endostée

Légère	**0**
Modérée	**1**
Profonde	**2**

AUTRES CRITÈRES

Fracture pathologique	**+2**
Masse des parties molles	**+4**
Cancer primitif connu	**+2**

CATÉGORIES ET CONDUITE

CATÉGORIE	POINTS	EXEMPLES	CONDUITE
0 incomplet	—	Risque non évaluable ; ex. lésion lytique du squelette axial (scapula, rachis, bassin)	Incidences supplémentaires ou imagerie en coupes
1 très faible risque	**1–2**	Lésion bénigne pathognomonique, « à ne pas toucher » : fibrome non ossifiant, ostéome ostéoïde	Asymptomatique : bilan terminé ou surveillance annuelle ; symptomatique : imagerie avancée, avis orthopédique
2 faible risque	**3–4**	Lésion lytique géographique asymptomatique sans réaction périostée suspecte ni érosion profonde ; ex. enchondrome, tumeur à cellules géantes, kyste anévrismal	Contrôle rapproché à **3–6 mois** ; imagerie avancée ± biopsie si besoin ; avis orthopédie oncologique à discuter
3 intermédiaire	**5–6**	Lésion géographique mal limitée ; lésion géographique chez un patient avec cancer connu	**Avis orthopédie oncologique** pour biopsie probable ; scanner, IRM ou scintigraphie
4 haut risque	**≥ 7**	Lésion non géographique, ou géographique avec réaction périostée agressive ou masse des parties molles	**Maligne jusqu'à preuve du contraire** : centre de référence, biopsie planifiée, bilan d'extension

PIÈGES

Biopsie
toujours planifiée avec le chirurgien du centre de référence (trajet)

Contexte
âge, siège (épiphyse, métaphyse, diaphyse), nombre de lésions orientent le diagnostic

Ostéomyélite
et histiocytose peuvent être agressives : clinique et biologie

Lésions « à ne pas toucher »
fibrome non ossifiant, îlot condensant typique : pas de biopsie

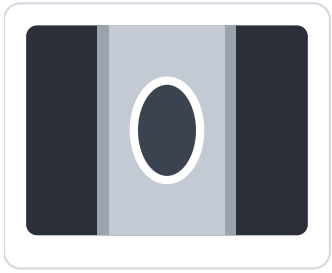
OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-01

Lésion osseuse solitaire · Bone-RADS (suite)

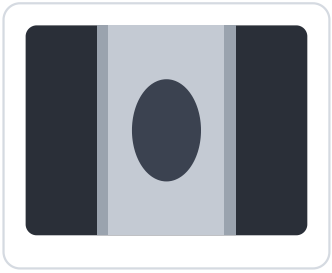
ACR Bone-RADS v2023
radiographie · score par points

ATLAS VISUEL

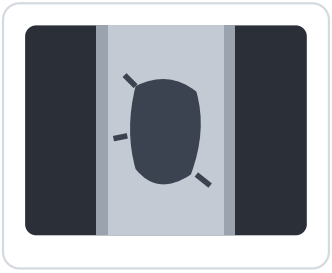
Marges (Lodwick) et réactions périostées



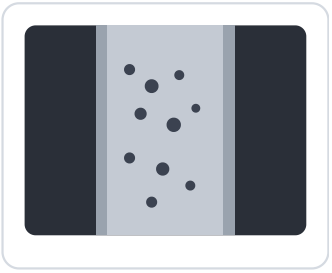
IA
géographique, bord scléreux · 1 pt



IB
bien limitée, sans sclérose · 3 pts



II
géographique mal limitée · 5 pts



III
mitée ou perméative · 7 pts



Périostée solide
non agressive · 2 pts



Lamellée
« bulbe d'oignon » · 4 pts



Spiculée
« feu d'herbe » · 4 pts



Éperon de Codman
agressive · 4 pts

Schémas simplifiés, non à l'échelle · os long en radiographie

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Bone-RADS
Radiopaedia · score par points
radiopaedia.org/articles/bone-reporting-and-data

Classification de Lodwick
Radiopaedia · types de marges
radiopaedia.org/articles/lodwick-classification-

Réactions périostées
Radiopaedia · agressives ou non
radiopaedia.org/articles/periosteal-reaction

Fibrome non ossifiant
Radiopaedia · lésion « à ne pas toucher »
radiopaedia.org/articles/non-ossifying-fibroma-1

Sources : ACR Bone-RADS v2023 Assessment Categories – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Bone-RADS/Bone-RADS-v2023-... · Bone-RADS v2023 breakdown (Radiopaedia) – prod-images-static.radiopaedia.org/page_images/5146/R24-214_...

Aide-mémoire pour radiologues et internes · ne remplace pas les recommandations originales ni la discussion multidisciplinaire · mise à jour octobre 2026